

CURSO EM PDF — PSIQUIATRIA FORENSE

Imputabilidade Penal e Capacidade Civil

Material robusto de estudo e aplicação pericial baseado no tema do Capítulo 18 de Genival Veloso de França.

Preparado para: Dr. Luís Henrique B. Gomes — Psiquiatra.

Uso: estudo, consulta, estruturação de laudos, entrevista pericial e respostas a quesitos.

Nota: material autoral/sintético. Não reproduz o livro; organiza o raciocínio médico-legal para uso prático.

Aula Robusta — Imputabilidade Penal e Capacidade Civil

Base de estudo: Capítulo 18 de Genival Veloso de França, Medicina Legal, 11^a edição.

Material autoral, aplicado à prática de psiquiatria forense. O objetivo é transformar os conceitos do capítulo em ferramenta de trabalho para perícias criminais, cíveis, administrativas e pareceres técnicos. Não reproduz o livro; organiza, amplia e operacionaliza os temas para uso médico-pericial.

1. Por que este tema é central para o psiquiatra perito

O Capítulo 18 trata de uma das zonas mais sensíveis da psiquiatria forense: a fronteira entre transtorno mental, responsabilidade penal, autonomia civil e proteção jurídica.

Na prática, o psiquiatra é chamado para responder perguntas como:

- o acusado tinha capacidade de entender o caráter ilícito do fato?
- conseguia se determinar conforme esse entendimento?
- o transtorno mental aboliu ou reduziu sua responsabilidade penal?
- há indicação de medida de segurança?
- o indivíduo tem capacidade civil para gerir bens, assinar contratos, casar, testar, consentir, vender patrimônio ou constituir procurador?
- a curatela é necessária?
- se sim, deve ser total ou parcial?
- há simulação, dissimulação ou exagero de sintomas?

O ponto central é este:

Diagnóstico psiquiátrico não decide imputabilidade nem capacidade civil. O que decide é a repercussão do transtorno sobre discernimento,

autodeterminação, funcionalidade e o ato juridicamente relevante.

Essa frase deve orientar toda perícia.

2. Mapa mental da aula

O tema se organiza em dois grandes blocos:

Bloco penal

Avalia responsabilidade penal.

Pergunta-chave:

No momento do fato, o examinado possuía capacidade de entender o caráter ilícito e de se determinar conforme esse entendimento?

Categorias práticas:

- imputável;
- semi-imputável;
- inimputável;
- inconclusivo por insuficiência de dados.

Bloco civil

Avalia autonomia para atos da vida civil.

Pergunta-chave:

O examinado possui capacidade atual ou retrospectiva para compreender, decidir, consentir e gerir atos civis específicos?

Categorias práticas:

- capaz;
 - capaz com apoio;
 - parcialmente incapaz para determinados atos;
 - incapaz para atos específicos;
 - inconclusivo por insuficiência de dados.
-

3. Conceitos fundamentais

3.1 Imputabilidade penal

Imputabilidade penal é a capacidade psíquica de ser responsabilizado penalmente por uma conduta.

Na formulação médico-pericial, envolve dois componentes:

1. Capacidade de entendimento.
2. Capacidade de autodeterminação.

Capacidade de entendimento

É a aptidão para compreender:

- a natureza do ato;
- o significado social da conduta;
- o caráter proibido/ilícito;
- as consequências previsíveis;
- a diferença entre certo e errado naquele contexto.

Capacidade de autodeterminação

É a aptidão para:

- controlar impulsos;
- inibir comportamento;
- agir conforme o entendimento preservado;
- resistir a comando delirante, impulso patológico ou estado mental desorganizador;
- escolher conduta alternativa.

Na prática, um indivíduo pode entender a ilicitude, mas estar com a autodeterminação gravemente comprometida. O contrário também pode ocorrer, embora seja menos comum em certos quadros.

3.2 Imputação

Imputabilidade é a condição psíquica abstrata. Imputação é a atribuição concreta do fato ao agente.

Exemplo:

- imputabilidade: o examinado tinha capacidade penal?
- imputação: aquele fato específico pode ser atribuído a ele como responsável?

O perito não decide a imputação jurídica final, mas fornece elementos sobre a capacidade mental no momento relevante.

3.3 Inimputabilidade

Inimputabilidade é a ausência de capacidade penal juridicamente relevante, por comprometimento psíquico grave.

Do ponto de vista pericial, a conclusão exige demonstrar:

- transtorno mental ou desenvolvimento mental incompleto/retardado;
- presença no momento do fato;
- impacto sobre entendimento e/ou autodeterminação;
- nexos entre o transtorno e a conduta;
- ausência de elementos que indiquem crítica preservada incompatível com abolição da capacidade.

3.4 Semi-imputabilidade

Semi-imputabilidade é a redução relevante, mas não abolição completa, da capacidade de entendimento ou autodeterminação.

É uma categoria pericial delicada porque exige gradação. O perito deve evitar frases vagas como “tinha certa dificuldade” ou “apresentava sofrimento psíquico”.

É necessário explicar:

- qual função estava prejudicada;
- em que grau;
- por qual transtorno;
- em que momento;

- com qual relação com o fato.

3.5 Capacidade civil

Capacidade civil é a aptidão para praticar atos da vida civil e gerir a própria pessoa e patrimônio.

Na avaliação psiquiátrica, deve-se analisar quatro componentes decisórios:

1. Compreensão: entende a informação relevante?
2. Apreciação: percebe que a informação se aplica a si?
3. Raciocínio: compara riscos, benefícios e alternativas?
4. Expressão de escolha: comunica decisão estável e coerente?

Também se avalia funcionalidade concreta:

- administração financeira;
 - cuidado com saúde;
 - moradia;
 - proteção contra abuso;
 - capacidade de contratar;
 - capacidade de outorgar procuração;
 - gestão de benefícios;
 - decisões familiares;
 - consentimento para tratamento.
-

4. Diferenças essenciais entre perícia penal e perícia civil

4.1 Perícia penal

A perícia penal costuma ser retrospectiva.

O objeto é o estado mental no momento do fato.

Dados importantes:

- comportamento antes do fato;
- motivação aparente;
- planejamento;
- escolha de vítima/local/horário;
- tentativa de fuga;
- ocultação de provas;
- relato de testemunhas;
- sintomas psicóticos ou afetivos no período;
- uso de substâncias;
- histórico de tratamento;
- internações;
- prontuários;
- exames toxicológicos;
- coerência entre quadro clínico e conduta.

4.2 Perícia civil

A perícia civil pode ser atual ou retrospectiva.

O objeto é a capacidade para atos civis específicos.

Dados importantes:

- diagnóstico atual;
- curso longitudinal;

- capacidade cognitiva;
- funcionalidade cotidiana;
- autonomia financeira;
- entendimento de contratos;
- risco de manipulação;
- suporte familiar;
- conflitos de interesse;
- preservação de direitos existenciais;
- necessidade e extensão de curatela.

4.3 Fórmula prática

No penal:

O transtorno mental afetou a responsabilidade pelo fato?

No civil:

O transtorno mental afeta a autonomia para atos da vida civil?

5. O que o perito deve evitar

5.1 Evitar diagnóstico automático

Errado:

“É esquizofrênico, portanto inimputável.”

Correto:

“Apresenta esquizofrenia; deve-se avaliar se, no momento do fato, havia sintomas psicóticos ativos com repercussão sobre entendimento ou autodeterminação.”

5.2 Evitar moralização

O perito não deve chamar o examinado de mau, perverso, frio, manipulador ou perigoso sem base técnica. Deve descrever comportamento, achados e inferências.

5.3 Evitar juridiquês decisório

O perito não sentencia. O perito fornece conclusão médico-legal.

Evitar:

“Deve ser condenado.”

Usar:

“Sob perspectiva médico-legal, não foram identificados elementos psiquiátricos capazes de abolir ou reduzir sua capacidade de entendimento e autodeterminação no momento do fato.”

5.4 Evitar curatela genérica

Na capacidade civil, evitar:

“Incapaz para os atos da vida civil.”

Preferir:

“Apresenta incapacidade para atos patrimoniais complexos, como contratos, empréstimos, alienação de bens e movimentação bancária de maior vulto, preservando capacidade para atos existenciais e decisões cotidianas simples.”

6. Modificadores biopsicossociais: como usar na perícia

O capítulo aborda vários fatores que podem influenciar imputabilidade e capacidade civil. Eles não são conclusões automáticas. Funcionam como elementos de contexto.

6.1 Idade

Crianças e adolescentes

A idade se relaciona com maturidade psíquica, desenvolvimento moral, impulsividade e compreensão de consequências. Em adolescentes, a avaliação deve distinguir:

- imaturidade típica;
- transtorno mental;
- deficiência intelectual;
- uso de substâncias;
- dinâmica familiar/social;
- ato infracional impulsivo versus planejado.

Idosos

Em idosos, pensar em:

- transtorno neurocognitivo maior ou menor;
- delirium;
- depressão pseudodemencial;
- vulnerabilidade a golpes;
- abuso patrimonial;
- capacidade para consentir;
- capacidade para testamento, venda de bens e procuração.

6.2 Sexo/gênero e contexto sociocultural

Não devem ser usados como justificativas automáticas. O papel pericial é verificar se há elemento clínico real que interfira em capacidade ou responsabilidade, evitando estereótipos.

6.3 Surdez, mutismo, cegueira e deficiência sensorial

Deficiência sensorial não equivale a incapacidade mental.

Avaliar:

- comunicação efetiva;
- acesso à informação;
- escolarização;
- linguagem;
- compreensão;
- autonomia;
- necessidade de intérprete ou adaptação.

6.4 Estados emotivos

Estados emocionais intensos podem influenciar conduta, mas não bastam para excluir imputabilidade.

Perguntas úteis:

- houve reação imediata e proporcional ao estímulo?
- havia transtorno mental subjacente?
- houve planejamento?
- houve fuga ou ocultação?
- o examinado compreendeu o que fazia?
- o estado emocional aboliu autodeterminação ou apenas reduziu controle?

6.5 Embriaguez e substâncias

Embora o capítulo específico de embriaguez seja outro, no contexto da imputabilidade ela sempre aparece.

Avaliar:

- tipo de substância;
- quantidade;
- voluntariedade;
- tolerância;
- sinais clínicos;
- amnésia real ou alegada;
- nexo temporal;
- exame toxicológico;
- comportamento complexo durante o fato.

Cuidado: intoxicação voluntária comum geralmente não equivale a inimputabilidade. Mas intoxicações patológicas, delirium, psicose induzida por substância e abstinência grave exigem análise específica.

6.6 Retardo mental / deficiência intelectual

Avaliar:

- funcionamento intelectual;
- funcionamento adaptativo;
- autonomia prática;
- sugestionabilidade;
- compreensão de ilicitude;
- vulnerabilidade a coautores;
- capacidade de consentimento;
- capacidade de gerir bens.

Não basta QI. A funcionalidade adaptativa é decisiva.

6.7 Epilepsia

Perguntas práticas:

- houve crise documentada?

- havia alteração de consciência?
- havia automatismo?
- o ato foi simples ou complexo?
- houve orientação após o evento?
- há período pós-ictal compatível?
- há exames neurológicos?
- há histórico de crises semelhantes?

Condutas complexas, prolongadas, com planejamento e ocultação tendem a ser menos compatíveis com automatismo epiléptico puro.

6.8 Prodigalidade

Na prática civil, prodigalidade pode decorrer de:

- mania;
- hipomania grave;
- transtorno por jogos;
- uso de substâncias;
- deficiência intelectual;
- demência frontotemporal;
- transtornos de personalidade;
- impulsividade grave.

Perguntas úteis:

- há dano patrimonial objetivo?
 - há incapacidade de avaliar consequências?
 - há repetição apesar de perdas?
 - há exploração por terceiros?
 - há transtorno mental explicativo?
 - que atos precisam ser restringidos?
-

7. Transtornos mentais e repercussão médico-legal

7.1 Esquizofrenia e psicoses

A esquizofrenia pode ter alto impacto forense quando há sintomas ativos relacionados ao fato.

Sinais relevantes:

- delírios persecutórios;
- alucinações imperativas;
- desorganização grave;
- comportamento bizarro;
- prejuízo de crítica;
- perda de contato com a realidade;
- abandono terapêutico;
- internações próximas ao fato.

Perguntas para o laudo:

- o conteúdo delirante motivou a conduta?
- havia crítica sobre os sintomas?
- o ato foi defensivo dentro da lógica delirante?
- houve planejamento racional externo ao delírio?
- havia tentativa de ocultação incompatível com desorganização?

Conclusão possível:

Em quadros psicóticos, o diagnóstico só terá relevância penal quando demonstrada relação funcional entre a psicose ativa e o fato imputado.

7.2 Transtorno bipolar

A relevância pericial é maior em mania, episódio misto, depressão grave psicótica ou impulsividade patológica em contexto afetivo.

Sinais relevantes:

- humor elevado/irritável;
- grandiosidade;
- redução da necessidade de sono;
- aceleração psicomotora;
- pressão de fala;
- desinibição sexual/financeira;
- gastos excessivos;
- ideias delirantes congruentes ou incongruentes com humor;
- internação ou medicação recente.

No civil:

- contratos em mania;
- doações atípicas;
- compras vultosas;
- procurações indevidas;
- risco patrimonial.

No penal:

- agressões em mania irritável;
- delitos impulsivos;
- condutas sexuais desinibidas;
- risco de superestimar inimputabilidade se havia planejamento e crítica.

7.3 Transtornos delirantes

A questão é o nexo entre delírio e conduta.

Exemplo:

- delírio de ciúme e agressão ao parceiro;
- delírio persecutório e ataque a suposto perseguidor;
- delírio somático e condutas contra profissional de saúde.

Se o ato decorre diretamente do delírio, pode haver forte impacto sobre entendimento ou autodeterminação.

7.4 Transtornos de personalidade

Em geral, transtornos de personalidade não abolirão imputabilidade. Podem explicar padrão de comportamento, mas não necessariamente reduzir responsabilidade.

Avaliar:

- impulsividade;
- agressividade;
- planejamento;
- frieza instrumental;
- empatia reduzida;
- manipulação;
- uso de substâncias;
- comorbidades;
- psicose transitória ou dissociação em situações extremas.

Cuidado técnico:

Transtorno de personalidade não é sinônimo de incapacidade de entendimento. Também não deve ser usado como rótulo moral.

7.5 Borderline

Pode envolver:

- instabilidade afetiva;
- impulsividade;
- autoagressão;
- medo de abandono;
- crises dissociativas;
- ideação paranoide transitória sob estresse.

Pergunta pericial:

A crise afetiva/dissociativa reduziu de forma juridicamente relevante a autodeterminação, ou havia capacidade preservada apesar de sofrimento intenso?

7.6 Transtornos do controle dos impulsos

Exemplos:

- cleptomania;
- piromania;
- jogo patológico;
- transtorno explosivo intermitente.

Perguntas:

- há impulso irresistível ou apenas não resistido?
- há tensão antes e alívio depois?
- há ganho externo?
- há planejamento?
- há padrão repetitivo?
- há comorbidade?

A distinção entre impulso irresistível e impulso não resistido é essencial, embora difícil.

7.7 Transtornos neurocognitivos

Relevantes para capacidade civil e, em alguns casos, penal.

Avaliar:

- memória;
- orientação;
- linguagem;
- funções executivas;

- julgamento;
- capacidade financeira;
- reconhecimento de familiares;
- risco de golpes;
- consentimento;
- alteração comportamental frontal.

Na demência frontotemporal, atenção especial para desinibição, perda de crítica, mudanças de personalidade, impulsividade e atos socialmente inadequados.

8. Capacidade civil aplicada à prática pericial

8.1 Capacidade não é global por padrão

A capacidade deve ser avaliada por domínio.

O periciando pode ser incapaz para:

- vender imóvel;
- contrair empréstimo;
- gerir benefício;
- administrar empresa;
- assinar contrato complexo;

mas capaz para:

- decidir onde morar;
- manter convivência familiar;
- expressar preferências afetivas;
- consentir em cuidados simples;
- participar de decisões com apoio.

8.2 Atos patrimoniais versus existenciais

Atos patrimoniais

Exigem maior capacidade de cálculo, previsão de consequências, proteção contra abuso e compreensão de contratos.

Atos existenciais

Incluem escolhas pessoais, afetivas, sociais, familiares, religiosas e de convivência. Devem ser preservados sempre que possível.

8.3 Curatela proporcional

A curatela deve ser:

- necessária;
- proporcional;
- delimitada;
- preferencialmente parcial;
- revisável;
- menos restritiva possível.

Formulação adequada:

Sugere-se curatela limitada aos atos patrimoniais e negociais complexos, preservando-se os direitos existenciais, afetivos, sociais e decisões cotidianas simples.

8.4 Tomada de decisão apoiada

Quando há autonomia parcial, mas necessidade de suporte, considerar tomada de decisão apoiada ou medidas de apoio familiar/institucional.

Perguntas:

- o examinado reconhece pessoas de confiança?
 - compreende o papel dos apoiadores?
 - consegue expressar preferências?
 - aceita suporte sem coerção?
 - há conflito de interesse familiar?
-

9. Entrevista pericial dirigida — imputabilidade penal

9.1 Dados iniciais

- identificação anonimizada;
- escolaridade;
- profissão;
- histórico psiquiátrico;
- histórico neurológico;
- uso de substâncias;
- antecedentes criminais;
- tratamento atual;
- medicações;
- internações;
- histórico familiar.

9.2 Reconstrução do momento do fato

Perguntas úteis:

1. O que o examinado lembra antes do fato?
2. Onde estava?
3. Com quem estava?
4. Havia uso de álcool/drogas?
5. Havia privação de sono?
6. Havia sintomas psicóticos?
7. Havia ameaça percebida?
8. O ato foi planejado?
9. Houve escolha de meio, local ou vítima?
10. O que fez depois?
11. Tentou fugir?
12. Tentou ocultar provas?

13. Procurou ajuda?

14. Demonstrou arrependimento, perplexidade ou indiferença?

15. Como explica hoje o ocorrido?

9.3 Avaliação do entendimento

Perguntas:

- você sabia que aquilo era proibido?
- sabia que poderia causar dano?
- sabia que poderia ser preso/processado?
- o que achava que estava acontecendo naquele momento?
- havia alguma voz, mensagem, sinal ou perseguição?
- havia alguma obrigação interna ou externa para agir?

9.4 Avaliação da autodeterminação

Perguntas:

- conseguiu pensar em não fazer?
 - tentou se controlar?
 - sentia que podia escolher outra conduta?
 - o impulso parecia controlável?
 - houve tempo para refletir?
 - houve escalada emocional?
 - já tinha acontecido antes?
-

10. Entrevista pericial dirigida — capacidade civil

10.1 Compreensão

- sabe por que está sendo avaliado?
- entende o processo?
- sabe o que é curatela/interdição/TDA?
- entende seus bens, renda e despesas?
- compreende contrato, empréstimo, venda, procuração?

10.2 Apreciação

- reconhece suas limitações?
- entende consequências para si?
- reconhece riscos de golpes?
- reconhece necessidade de ajuda?

10.3 Raciocínio

- compara alternativas?
- calcula consequências?
- explica motivos da decisão?
- muda de opinião de forma coerente ou aleatória?

10.4 Expressão de escolha

- expressa preferência clara?
- mantém decisão estável?
- sofre pressão externa?
- consegue dizer não?

10.5 Funcionalidade

- administra dinheiro?
- paga contas?

- usa banco/aplicativo?
 - compra alimentos/remédios?
 - organiza medicação?
 - mora sozinho?
 - reconhece familiares?
 - cuida da higiene?
 - comparece a consultas?
 - já sofreu golpes?
-

11. Exame do estado mental com foco forense

Além do EEM clássico, destacar:

- aparência e autocuidado;
 - atitude frente à perícia;
 - colaboração;
 - orientação;
 - atenção;
 - memória imediata, recente e remota;
 - linguagem;
 - pensamento formal;
 - conteúdo delirante;
 - ideias de referência/perseguição/ciúme/grandiosidade;
 - alucinações;
 - humor e afeto;
 - controle de impulsos;
 - crítica/insight;
 - julgamento;
 - capacidade de abstração;
 - coerência narrativa;
 - inconsistências;
 - sugestionabilidade;
 - risco suicida/heteroagressivo;
 - capacidade decisória observável.
-

12. Documentos essenciais

Penal

- denúncia/queixa;
- boletim de ocorrência;
- depoimentos;
- imagens/áudios;
- laudos toxicológicos;
- prontuários psiquiátricos;
- relatórios médicos prévios;
- internações;
- receitas;
- histórico prisional;
- exame de corpo de delito;
- documentos próximos ao fato.

Civil

- petição inicial;
 - documentos médicos;
 - laudos neuropsicológicos;
 - exames de imagem/laboratoriais quando pertinentes;
 - extratos financeiros se houver prodigalidade/golpes;
 - contratos questionados;
 - procurações;
 - relatórios sociais;
 - documentos de familiares;
 - avaliações anteriores;
 - histórico de cuidados.
-

13. Simulação, dissimulação e inconsistência

13.1 Simulação

Produção ou exagero intencional de sintomas por ganho externo.

13.2 Dissimulação

Ocultação de sintomas ou prejuízos, comum quando o examinado quer parecer capaz ou imputável, ou evitar internação/curatela.

13.3 Inconsistência não é sinônimo de simulação

Pode decorrer de:

- psicose;
- deficiência intelectual;
- demência;
- baixa escolaridade;
- ansiedade;
- vergonha;
- medo;
- trauma;
- má compreensão da pergunta.

Formulação prudente:

Foram observadas inconsistências entre relato, documentos e exame, as quais reduzem a confiabilidade de determinados dados e exigem cautela interpretativa. Tais inconsistências, isoladamente, não permitem afirmar simulação sem elementos adicionais.

14. Modelos de conclusão para uso em laudos

14.1 Penal — imputabilidade preservada

O examinado apresenta diagnóstico de [DIAGNÓSTICO], contudo os elementos clínicos e documentais disponíveis não demonstram que, ao tempo do fato, tal condição tenha abolido ou reduzido de modo juridicamente relevante sua capacidade de entender o caráter ilícito da conduta ou de se determinar conforme esse entendimento. Sob perspectiva médico-legal, não há elementos psiquiátricos suficientes para afastar a imputabilidade penal.

14.2 Penal — semi-imputabilidade

O examinado apresenta [DIAGNÓSTICO], com evidências de que, ao tempo do fato, havia comprometimento parcial de [ENTENDIMENTO/AUTODETERMINAÇÃO], relacionado a [SINTOMAS]. Tal comprometimento não aboliu completamente sua capacidade penal, mas a reduziu de forma relevante. Sob perspectiva médico-legal, os achados são compatíveis com redução parcial da capacidade de entendimento e/ou autodeterminação.

14.3 Penal — inimputabilidade

O examinado apresenta [DIAGNÓSTICO], com elementos clínicos e documentais indicativos de que, ao tempo do fato, encontrava-se em estado de [DESCREVER ESTADO PSICOPATOLÓGICO], o qual comprometeu de forma total sua capacidade de [ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO / DETERMINAR-SE CONFORME ESSE ENTENDIMENTO]. Há nexos entre o quadro psicopatológico e a conduta descrita. Sob perspectiva médico-legal, os achados são compatíveis com inimputabilidade penal.

14.4 Penal — inconclusivo

Os dados disponíveis são insuficientes para reconstruir com segurança o estado mental do examinado ao tempo do fato. Embora haja referência a [DADOS], faltam elementos contemporâneos suficientes sobre sintomas, comportamento, uso de substâncias, tratamento e funcionalidade. Assim, não é possível concluir, com segurança médico-pericial, sobre imputabilidade, semi-imputabilidade ou inimputabilidade.

14.5 Civil — capacidade preservada

O examinado apresenta [DIAGNÓSTICO/SINTOMAS], porém mantém compreensão, apreciação, raciocínio decisório e expressão de vontade estável para os atos avaliados. Não foram identificados prejuízos funcionais suficientes para justificar restrição de capacidade civil nos dados fornecidos.

14.6 Civil — curatela parcial

O examinado apresenta [DIAGNÓSTICO], com prejuízos em [DOMÍNIOS], repercutindo especialmente sobre [ATOS PATRIMONIAIS/NEGOCIAIS/SAÚDE]. Preserva, entretanto, capacidade para [ATOS PRESERVADOS]. Sob perspectiva médico-pericial, recomenda-se medida proporcional e limitada aos atos [ESPECIFICAR], preservando-se direitos existenciais e decisões cotidianas simples.

14.7 Civil — incapacidade ampla

O examinado apresenta comprometimento grave e global de [COGNIÇÃO/JUÍZO/FUNCIONALIDADE], com incapacidade de compreender, apreciar, raciocinar e expressar escolha estável quanto aos atos civis avaliados. Os achados sustentam necessidade de representação ampla, ressalvada a preservação de direitos existenciais na máxima extensão compatível com sua condição clínica.

15. Quesitos frequentes e respostas-modelo

Quesito 1 — O periciando é portador de doença mental?

Resposta-modelo:

Sim/Não. Com base em [ENTREVISTA/EXAME/DOCUMENTOS], o periciando apresenta quadro compatível com [DIAGNÓSTICO]. A conclusão diagnóstica fundamenta-se em [SINTOMAS/EVOLUÇÃO/DOCUMENTOS].

Quesito 2 — A doença mental compromete sua imputabilidade?

O diagnóstico, isoladamente, não permite concluir sobre imputabilidade. No caso concreto, deve-se avaliar se, ao tempo do fato, havia prejuízo da capacidade de entendimento e/ou autodeterminação. Com base nos dados disponíveis, [HÁ/NÃO HÁ/NÃO É POSSÍVEL AFIRMAR] comprometimento relevante.

Quesito 3 — O periciando entendia o caráter ilícito do fato?

Os elementos disponíveis indicam que [ENTENDIA/NÃO ENTENDIA/NÃO É POSSÍVEL CONCLUIR], considerando [JUÍZO DE REALIDADE, PSICOSE, PLANEJAMENTO, FUGA, RELATO, DOCUMENTOS].

Quesito 4 — Podia se determinar conforme esse entendimento?

A capacidade de autodeterminação encontrava-se [PRESERVADA/REDUZIDA/ABOLIDA/INDETERMINADA], em razão de [ACHADOS].

Quesito 5 — Há risco de reiteração ou periculosidade?

A avaliação de risco deve considerar diagnóstico, histórico de violência, adesão ao tratamento, uso de substâncias, suporte social, crítica, impulsividade e comportamento recente. No caso concreto, [DESCREVER FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO].

Quesito 6 — O periciando é capaz para os atos da vida civil?

A capacidade civil deve ser analisada por ato e domínio funcional. No caso concreto, há preservação de [DOMÍNIOS] e prejuízo em [DOMÍNIOS], recomendando-se [CONCLUSÃO].

Quesito 7 — Há necessidade de curatela?

A necessidade de curatela depende de prejuízo funcional concreto e risco associado. Com base nos dados avaliados, [HÁ/NÃO HÁ] elementos para curatela, limitada a [ATOS], preservando [DIREITOS/ATOS].

16. Tabela prática: diagnóstico versus impacto forense

Quadro	Penal	Civil	Cuidado principal
Esquizofrenia ativa	Pode abolir/reduzir capacidade se ligada ao fato	Pode comprometer atos complexos	Demonstrar sintomas no momento relevante
Esquizofrenia estável	Nem sempre altera imputabilidade	Pode manter capacidade parcial/total	Não concluir por diagnóstico histórico
Mania	Pode reduzir autodeterminação	Pode invalidar atos patrimoniais	Documentar episódio e nexo temporal
Depressão grave psicótica	Pode afetar entendimento/autodeterminação	Pode afetar consentimento e gestão	Avaliar psicose, risco e cognição
Transtorno de personalidade	Geralmente não exclui imputabilidade	Pode afetar relações, raramente capacidade global	Evitar moralização
Demência	Pode afetar imputabilidade conforme gravidade	Frequentemente relevante para curatela	Avaliar funcionalidade por domínio
Deficiência intelectual	Pode reduzir entendimento e autodeterminação	Pode exigir apoio/curatela parcial	Avaliar funcionamento adaptativo
Uso de substâncias	Depende do tipo e contexto	Pode afetar atos se dependência grave	Diferenciar intoxicação voluntária, psicose e delirium
Simulação	Pode invalidar relato	Pode distorcer avaliação	Não afirmar sem base objetiva

17. Roteiro final para usar antes de concluir qualquer perícia

Antes de concluir, responder internamente:

1. Qual é o ato juridicamente relevante?
 2. A avaliação é atual ou retrospectiva?
 3. Qual diagnóstico está demonstrado?
 4. Quais sintomas estavam presentes no momento relevante?
 5. Qual função mental foi comprometida?
 6. O prejuízo foi cognitivo, volitivo, decisório ou funcional?
 7. Há nexo entre transtorno e ato?
 8. O grau de prejuízo é total, parcial ou ausente?
 9. Existem explicações alternativas?
 10. Há inconsistências ou simulação?
 11. A conclusão está proporcional aos achados?
 12. O texto separa fato, relato, documento e inferência?
-

18. Exercícios clínico-periciais

Exercício 1

Homem com histórico de esquizofrenia, sem tratamento há 8 meses, agride desconhecido após afirmar que este “transmitia mensagens de ameaça pelo olhar”. Testemunhas relatam comportamento desorganizado nos dias anteriores.

Tarefa:

- formular hipótese de imputabilidade;
- listar documentos necessários;
- indicar perguntas para entrevista;
- escrever conclusão provisória.

Exercício 2

Mulher de 72 anos vende imóvel por valor muito inferior ao mercado a pessoa recém-conhecida. Família relata esquecimento progressivo, repetição de perguntas e dificuldade com banco. Ela afirma que “entendeu tudo”, mas não sabe explicar preço, consequência ou destino do dinheiro.

Tarefa:

- avaliar capacidade civil;
- delimitar atos preservados e comprometidos;
- propor curatela ou apoio;
- escrever conclusão.

Exercício 3

Acusado com transtorno de personalidade antissocial comete fraude elaborada, cria documentos falsos e tenta ocultar transações. Defesa alega transtorno mental.

Tarefa:

- explicar por que diagnóstico não basta;
- avaliar entendimento e autodeterminação;

- redigir resposta a quesito.

Exercício 4

Paciente bipolar em mania franca doa grande parte do patrimônio, contrai empréstimos, compra três veículos e afirma ter “missão divina de redistribuir riqueza”. Há internação psiquiátrica 10 dias depois.

Tarefa:

- avaliar capacidade para os atos civis no período;
 - relacionar sintomas com decisões;
 - redigir conclusão civil retrospectiva.
-

19. Como transformar esta aula em prática diária

Para cada perícia, use esta sequência:

1. Defina se o caso é penal ou civil.
 2. Identifique o ato juridicamente relevante.
 3. Monte a linha do tempo clínica e jurídica.
 4. Faça EEM dirigido ao domínio pericial.
 5. Separe diagnóstico de capacidade.
 6. Analise entendimento, autodeterminação e funcionalidade.
 7. Delimite grau e extensão do prejuízo.
 8. Responda quesitos com linguagem objetiva.
 9. Declare limitações.
 10. Evite conclusão maior do que os dados permitem.
-

20. Frase final da aula

A boa perícia psiquiátrica não pergunta apenas “qual é o diagnóstico?”.
Pergunta: “que função mental foi comprometida, em que grau, em qual momento, com que nexos com o ato e com quais consequências jurídicas possíveis?”.

Anexo — Plano de estudo sugerido

Como estudar esta apostila

1. Leia os conceitos fundamentais antes de estudar transtornos específicos.
2. Em seguida, pratique a diferença entre perícia penal e civil.
3. Use os checklists antes de redigir laudos.
4. Treine as respostas-modelo a quesitos.
5. Refaça os casos práticos substituindo os dados por situações reais anonimizadas.

Sequência de estudo em 6 encontros

Encontro 1 — Conceitos centrais

Imputabilidade, imputação, inimputabilidade, semi-imputabilidade e capacidade civil.

Encontro 2 — Penal versus civil

Diferença entre estado mental no momento do fato e capacidade para atos da vida civil.

Encontro 3 — Transtornos mentais

Psicoses, bipolaridade, demências, deficiência intelectual, personalidade e substâncias.

Encontro 4 — Entrevista e exame

Perguntas dirigidas, exame do estado mental forense e documentos essenciais.

Encontro 5 — Conclusões e quesitos

Modelos de conclusão, respostas a quesitos e linguagem técnica.

Encontro 6 — Casos práticos

Aplicação do raciocínio a casos de psicose, mania, demência e transtorno de personalidade.

Anexo — Modelo de folha de raciocínio pericial

Identificação do problema

- Tipo de perícia: [PENAL / CIVIL]
- Ato juridicamente relevante: [DESCREVER]
- Momento relevante: [DATA/PERÍODO]
- Documentos principais: [LISTAR]

Diagnóstico e sintomas

- Diagnóstico provável: [DESCREVER]
- Sintomas ativos no momento relevante: [DESCREVER]
- Fontes: [ENTREVISTA / DOCUMENTOS / TESTEMUNHAS]

Funções afetadas

- Entendimento: [PRESERVADO / REDUZIDO / ABOLIDO / INDETERMINADO]
- Autodeterminação: [PRESERVADA / REDUZIDA / ABOLIDA / INDETERMINADA]
- Capacidade decisória civil: [DESCREVER]
- Funcionalidade: [DESCREVER]

Nexo

- Há nexo entre transtorno e ato? [SIM / NÃO / INDETERMINADO]
- Fundamentação: [DESCREVER]

Conclusão provisória

[IMPUTÁVEL / SEMI-IMPUTÁVEL / INIMPUTÁVEL / CAPAZ / INCAPAZ PARCIAL / INCONCLUSIVO]

Limitações

[DESCREVER DADOS AUSENTES OU CONFLITANTES]

Material elaborado para estudo médico-pericial. A conclusão técnica final deve ser validada pelo médico responsável em cada caso concreto.